

إسم المريض ربيعاً : علا رمضان محمد رزق
المحافظة : الفيوم الحي / المدينة : الفيوم
رقم البطاقة : 28502042300145 رقم التليفون : 01097063670
العمر(تاريخ الميلاد) : 04-02-1985 المهنة : بدون عمل
العنوان : علوايه سعاده- الصوفى
تاريخ تسجيل الإستمارة : 23-09-2026

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي (-----)
المقر بما فيه التوقيع: (-----)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج: أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج:** الاورام

التعليق على التشخيص : -----

GRI-٤

رستم خیل

مدرسہ اسلامیہ

صحة الامانيات المرفعة

للجنة ومدير

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: ----- التوقيع:

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس

وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

----- /د ----- /د ----- /د. | ----- /د. |

التشخيص النهائي :
 خطة العلاج :
 المستشفى :
 قسم :
 نفقات :
 ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

**مدير عام
مديرية الشؤون الصحية**

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: علا رمضان محمد رزق National ID: 28502042300145	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





Patient Name : السيده / علا رمضان محمد رزق
Patient No. : 28502042300145
Path No. : 6295/2024
Sex : Female
Age :
Referring Doc : Maro

Request No. : 110111610
Request Date : 25/08/2024
Verification Date : 04/09/2024
Financial Category : مبادرة
Department : مبادرة اورام ثدي - سوهاج

Pathology Report

CLINICAL DIAGNOSIS: Right breast mass at 10 o'clock towards axillary tail.

NATURE OF SPECIMEN: TCNB.

GROSS EXAMINATION : The specimen consists of 4 tissue cores (1.5cm long, each), grayish in color, totally submitted in one cassette.

MICROSCOPIC EXAMINATION: Sections revealed infiltration by atypical epithelial cells arranged in cords, nests, the cells show pleomorphism, hyperchromatic nuclei and rare mitosis, the stroma is desmoplastic.

DIAGNOSIS:

Labeled as right breast mass 10 o'clock towards axillary tail, TCNB:

- Features of invasive duct carcinoma, NST, GII.
- No ductal carcinoma in-situ component could be detected in examined section.

Signature

Pathologist.Dr: Ghada Mostafa

Dr. Cherry Gamal

N.B : Specimens received at the department of pathology are examined and sampled for diagnostic purposes. The specimens are normally held for four weeks and then disposed.

Patient Name : الأستاذ / علا رمضان محمد رزق	Request No. : 13004677
Patient No. : 28502042300145	Request Date : 06/11/2024
Path No. : 4273/24	Verification Date : 25/11/2024
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 39 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:

Right breast masses.

Nature of the specimen:

Right Simple mastectomy and sentenil lymph node biopsy specimens , collected at 6/11/2024.

Gross Examination:

Two specimens were recived :

- Sentenil lymph node biopsy specimen :Multiple fibrofatty tissue pieces measured 3x3 cm collectively enclosing 2 nodules measured 1.5x1x0.5 cm and 0.5x0.5x0.5 cm.
 - Simple mastectomy specimen measured 19x13x5 cm with covering skin elipse measured 19x13 cm .
 - Tumor extent
 - o Number: Two UOQ ill defined greyish white firm masses.
 - o Size:2.8x2x1.5 cm and 0.4x0.4x0.3 cm.
 - Distance from margins:The larger mass was located 0.2 cm from deep margin (inked). The distance between the two masses was 2.5 cm.
 - Frozen section:
 - Free SLNs (0/2).
 - Gross key:
 - 1,2) The larger mass with inked deep margin.
 - 3) Area inbetween two masses.
 - 4) Smaller mass.
 - 5) Nipple and areola.
 - 6) Sentenil lymph nodes.
- Gross done by Dr.Duaa Mohammed.

Verified by :
dr.esraa magdy

Printing Date : 26/11/2024 09:37:42

Page 1 of 2

Printing By : .marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name: Ola Ramadan Mohamed Rezk	Date : 23/07/2025
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 40 Year(s)
Medical ID: 3342/2024 470	Pat. ID: 79802

**LEFT BREAST MAMMOGRAPHY WITH BILATERAL
ULTRASOUND**

INDICATION:

Right MRM

TECHNIQUE:

- Left breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

REPORT:

- Dense parenchyma, (ACR C).
- No spiculated masses or grouped microcalcifications.
- Complementary U/S showed no left breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness and nipple-areola complex of the left breast.
- A benign calcification is seen.
- Left nonspecific axillary nodes, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free right operative bed with no evidence of recurrent mass lesions, and free infra and supra clavicular regions

OPINION:

- Right MRM with free operative bed.
- Apart from a benign calcification, essentially normal study of the left breast, (BIRADS 2).

**Best regards,
Dr. Mahi Mokhtar**

Name : Alaa Ramadan Mohammed

Date : 09-08-2025 10:03

Branch : Dokki

Medical No. : 171222

Ref.Physician Prof : Gostaf Roseh Hospital

Tc^{99m} MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY**History:**

- 40-year-old lady, with right breast cancer, referred for follow up.

Technique:

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of the tracer.

Findings:

Compared to prior study dated 17/10/02024:

- Still no abnormal active or cold focal bony lesions that may account for metastatic bone disease could be seen allover the surveyed skeleton.
- Pelvic positional tilt is noted.

Impression:

- The skeleton is keeping free from metastases.

Best regards,
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear Medicine

علا رمضان محمد

اسم المريض:-

التاريخ:- 2024/08/11

/د.ا

لطبيب المعالج:-

Sono-mamography examination of Bilateral Breast Revealed

ACR B: scattered fibro glandular breast tissue

Right breast:-

- UOQ irregular shaped highly dense lesion with speculated margins and coarse heterogeneous micro-calcifications seen at 10 o'clock towards the axillary tail, measuring about (19 x 17 mm) in its maximum transverse diameters. Such lesion showed increased peripheral vascularity on color Doppler study.
- Normal appearance of lactiferous ducts with no evidence of focal lesions within.
- Average skin thickness.
- No abnormal vascular pattern.
- Normal appearance of retro-mammary area and pectoral muscles.
- No intra-mammary Lymphadenopathy.
- Few nonspecific axillary lymph nodes are noted. They showed regular outlines and preserved fatty hilum

Left breast:-

- Normal fibro-glandular pattern with no evidence of solid masses or cystic lesions could be detected.
- Normal appearance of lactiferous ducts with no evidence of focal lesions within.
- Increased skin thickness.
- No abnormal vascular pattern.
- Normal appearance of retro-mammary area and pectoral muscles.
- Few nonspecific axillary lymph nodes are noted. They showed regular outlines and preserved fatty hilum



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

**MDT form**

A-Patient ID:

1- Name : علا رمضان محمد رزق

Sex:

Female

3- Medical number:

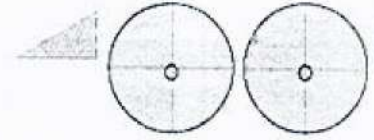
83234579

Old Med :

Old Med :
3342-2024

2-ID number:

Patient Age : 40 Y



Family history

Family History
-ve

Phone

Phone
01097603670

BMI

BMI

REASON OF MDT

REASON OF MDT
POST OPERATIVE

marital status

Marital Status
MARRIED

NRS Score

NRS Score

GROUP

GROUP
B

Date of MDT

Date of MDT

05/12/2024

Co morbidity

Co Morbidity
cardiac, MVPMenopausal
statusMenopausal Status
POSTMENOPAUSAL

Initial STAGE

Initial STAGE

Clinical data

Breast Imaging :

rt UOQ mass 19x17 mm+microcalcification
few non specific LN

Mets Workup :

cap: ill defined lucent areas of bilateral iliac bones+L3
vertebral body subtle lesion+sclerotic focus
bone scan: free

ER	PR	Her 2 Neu	SISH	Ki67
IDC	3/3	0		25
ER COMMENT:	PR COMMENT:	Her 2 Neu COMMENT:	SISH COMMENT:	

T	N	M
2m	0	0

Sonomammography

cesm: RT BREAST AXILLARY TAIL MASS SHOWING MODERATE MASS ENHANCEMENT WITH ANTERIOR
ENHANCING NODULES 86MM, NIPPLE RETRACTION WITH RETROAREOLAR NON MASS ENHANCEMENT

PATIENT HISTORY

upfront simple mastectomy+SLNB: bifocal mixed IDC+ILC pt2(2.8cm,0.4cm)

LN 0/2

free deep margin

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

for 1-adjvant taxotere endoxanx4

2-zoladex aromatase inhibitor + Zometa 13m

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY د/الام جميل	RADIOLOGY	RADIOLOGY د/رحاب البكري
SURGERY	SURGERY د/احمد فتح الله	PATHOLOGY	PATHOLOGY
Psychiatric	Psychiatric	Nutrition	Nutrition